6.治疗　内科:一般先有全身症状,再有局部症状 e.g 大叶性肺炎先有发热,再有局部的胸痛
外科:一般先有局部症状,再有全身症状 e.g 消化性溃疡穿孔先是突发上腹痛,过了8小时从化学性腹膜炎演变成化脓性腹膜炎后出现高热

①首先**禁食补液、胃肠减压** 最基础,有些症状轻的患者就不用再做手术

②对于饱餐后或弥漫性腹膜炎**最佳**治疗是**修补缝合术**（争取 8 小时内）过了8h也要做
6-8h内为化学性腹膜炎,过了6-8h细菌繁殖指数增长,变为化脓性腹膜炎

特殊:心梗为典型的内科性疾病,但是先有局部症状(痛),后由于大量心肌细胞坏死,坏死部位的吸收热,即出现全身症状

（三）幽门梗阻



1.临床表现

①**餐后很快腹痛、反复呕吐（隔夜酸宿食、不含胆汁）** 胆汁上不来

②**低钾低氯碱中毒** 排钾利尿剂也可以导致低钾低氯碱中毒

③胃型、胃蠕动波、**振水音** →见于幽门梗阻(消化系统)、液气胸(呼吸系统)

注意：低钾低氯碱中毒常见于肺心病等用利尿剂、幽门梗阻呕吐、肝硬化并发症等
禁用M受体拮抗剂解痉,因为此时已经梗阻,拮抗M受体平滑肌活动↓会加重梗阻

2.治疗　补钾后机体通过H+—K+交换代偿而解决碱中毒

①首先禁食、胃减压，补液（**补 KCl+平衡盐**或 5%葡萄糖盐水或生理盐水），高渗温盐水洗胃（减轻胃壁水肿）

②缓解→痉挛或水肿性为主；**不缓解→瘢痕性为主**→内镜或**胃大部切除术**（术前用抗生素）工工类切口:可能污染切口术前用抗生素
功能性问题　外科:瘢痕性幽门梗阻直接做胃大部切除术

（四）癌变（最少见）

1.GU-癌变率＜1%（**边缘**开始），**DU-不癌变** 胃镜取活检从边缘开始

肿瘤本身不痛,但会刺激包膜N导致疼痛

2.疼痛与体重减轻是胃癌最常见的症状：胃溃疡病史患者腹痛开始**不规律**、体重减轻、贫血，保守治疗＞8 周无效、**粪隐血可持续阳性**、**胃酸缺乏** A型胃炎、胃癌
"坏"持续出血
VS 胃溃疡不一定每次粪隐血都阳性

3.**手术**为主，配合化疗

五、消化性溃疡的内科治疗

（一）抑酸治疗最重要

1.**抑酸**药 胃蛋白酶原的激活需要胃酸,只要抑酸就可以抑蛋白,抑酸还可止血、杀HP、为杀HP抗生素提供合适环境

①**PPI：首选、最佳、维持治疗**，疗程 DU 约 4 周、GU 约 6-8 周（D 第 4 个、G 第 7 个字母）
GU保护因素减弱为主,胃酸分泌本来就不高,对抑酸治疗效果不如DU

②**P-CAB** 钾离子竞争性酸阻滞剂

③**H_2-RA**：法莫替丁 ttsx 最强

2.用 H_2-RA 维持治疗复发的半数以上是无症状溃疡（患者无腹痛，主要以出血、穿孔等为首发症状）
本身是一个抑酸药,减少了酸对溃疡面神经的刺激,腹痛不明显,但是并发症不会少

（二）根除 Hp

①**四联**疗法：**PPI+铋剂+2 种抗生素** 四克拉的镯子,让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人

②根除 Hp 所需的 1-2 周疗程可重叠在 4-8 周的抑酸疗程内、也可在抑酸疗程结束后进行
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑和替硝唑、阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮

（三）保护黏膜

①铋剂：肾功能不全者禁用 泌尿　(铋-泌)通过肾脏排泄

②米索前列醇（前列腺素类似物）：孕妇禁用（前列腺素使子宫强烈收缩可致流产等）

③抗酸剂（铝剂）中和酸而已

④预防 NSAIDs 所致消化性溃疡：PPI+米索前列醇 e.g 冠心病患者不能随便停阿司匹林
抑制COX-1导致PG↓　减少侵袭因素　增加保护因素　不用铋剂